

DOLOR ABDOMINAL AGUDO

Pablo Díez González

INTRODUCCIÓN

Concepto

El dolor abdominal es un síntoma inespecífico de multitud de procesos, que puede originarse por causas intraabdominales o procesos extraabdominales, incluso por enfermedades sistémicas. Lo más importante será reconocer aquellos procesos intraabdominales graves, que requieran una solución quirúrgica urgente, que definimos como abdomen agudo.

Abdomen agudo: el conjunto de signos y síntomas de variada etiología cuyo nexo común es el dolor abdominal intenso que origina un compromiso sistémico al paciente, llegando a producir shock y fracaso multiorgánico en cuestión de horas si no se identifica y trata adecuadamente.

Etiología

INFLAMATORIA-INFECCIOSA	ESTENÓTICA-OBSTRUCTIVA	GINECOLÓGICA	PERFORANTE	VASCULAR
• Apendicitis aguda • Colecistitis aguda • Colangitis aguda • Pancreatitis aguda • Diverticulitis • Megacolon tóxico (Enf. Inflamatoria intestinal)	• Cáncer colorrectal • Vólvulos de ciego y sigma • Adherencias y bridas (cirugías previas) • E. Crohn variante fibroestenótica-obstructiva • Bezoares	• Embarazo ectópico • Rotura de folículo ovárico o quiste lúteo • Salpingitis	• Úlcus gastroduodenal perforado • Cuerpos extraños • Estallido intestinal tras traumatismo u obstrucción evolucionada	• Isquemia mesentérica aguda • Aneurisma disecante de aorta • Colitis isquémica • Hemorragia intraperitoneal por rotura de víscera maciza por traumatismo o espontáneamente • Hernias estranguladas (cuadro mixto por componente obstructivo)

DIAGNÓSTICO

El objetivo de la valoración del dolor abdominal agudo en urgencias es establecer un diagnóstico y confirmarlo con las pruebas complementarias correspondientes; determinar la necesidad de un tratamiento quirúrgico o no. Aspectos fundamentales:

Clínica

Son muy útiles signos y síntomas tales como el inicio súbito de intensidad creciente, la irritación peritoneal o la alteración del tránsito intestinal.

Se debe de identificar la presencia o ausencia de algún signo específico que nos pueden orientar al diagnóstico.

- **Signo de Murphy.** Pedir que mantenga la respiración durante unos segundos luego palpar profundamente a nivel del hipocondrio derecho desencadenando dolor por distensión vesicular (característico de las colecistitis agudas).
- **Punto de Mac Burney.** Se localiza en la línea imaginaria que va desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior derecha en la unión del tercio externo con los dos tercios internos, al presionar en dicho punto produce dolor siendo muy sugestivo de apendicitis aguda

(aproximadamente 90% de los pacientes).

- **Signo de Blumberg.** Signo de irritación peritoneal, se genera dolor intenso a la descompresión manual brusca abdominal. Puede ser característico en la fosa ilíaca derecha, como por ejemplo de la apendicitis. Si esta misma maniobra de descompresión produce dolor en cualquier otra parte del abdomen se conoce como **Signo del rebote**.
- **Signo de Rovsing.** Al presionar sobre la fosa ilíaca izquierda en el punto simétrico al de Mac Burney produce dolor en el lado derecho nos orienta a un signo positivo frente a la apendicitis aguda.
- **Signo del Obturador.** Paciente en decúbito supino se pide que flexione la rodilla en ángulo recto 90° y se intenta una rotación interna o externa de la cadera derecha produciendo dolor en fosa ilíaca derecha sobre todo en hipogastrio (apendicitis aguda en situación pélvica).
- **Signo del Psoas.** Dolor en fosa ilíaca derecha con la hiperextensión pasiva o la flexión activa de la cadera derecha (apendicitis retrocecal), paciente en posición en decúbito supino, se pide que levante la extremidad inferior derecha y con la mano del examinador presionamos para evitar levantar la extremidad inferior derecha o paciente en decúbito lateral izquierdo se lleva la extremidad inferior derecha en extensión forzada produciendo dolor en fosa ilíaca derecha.

Tipo de dolor.

- **Somático o parietal:** Dolor agudo, lancinante, bien localizado por el paciente y que aumenta de intensidad con la palpación. Se produce por inflamación del peritoneo parietal. Generalmente es la expresión de un proceso grave que requiere intervención quirúrgica urgente (perforación).
- **Esplácnico o visceral:** Se produce por estimulación indirecta (distensión) o lesión de las terminaciones nerviosas situadas en la membrana serosa que envuelve los órganos internos. El organismo refiere el dolor a las metámeras superficiales circundantes, por esta razón se percibe difuso, impreciso (pancreatitis).
- **Referido:** Es consecuencia de la irritación nerviosa adyacente a la lesión desencadenando dolor a distancia (dolor epigástrico en apendicitis). Puede tener origen torácico y referido por el enfermo en algún punto del abdomen (neumonía y cardiopatía isquémica).

Vómitos

- Si se presentan tras el dolor orienta a un proceso agudo quirúrgico: colecistitis, apendicitis, oclusión intestinal, etc. Algunas veces modifican dicho dolor aliviando o empeorándolo.
- Es útil conocer su frecuencia, volumen y coloración, en los casos de oclusión ya que nos permite diferenciar si ésta es alta (escasos, frecuentes y verdosos) o baja (abundantes, espaciados y fecaloideos).

Hipo

- Se produce por hiperestimulación frénica en situaciones de irritación peritoneal secundaria a colecistitis, abscesos subfrénicos, etc.

Variación del tránsito intestinal

- Su ausencia más de 24 horas traduce una oclusión intestinal completa que indica intervención urgente. Es preciso distinguirla del íleo adinámico que puede aparecer concomitante con otras patologías. La diarrea puede presentarse asociada a apendicitis, pero es un signo infrecuente de abdomen agudo quirúrgico.

Exploración física

- **Inspección:** estado general del paciente, presencia de cicatrices, eventraciones, hernias,

distensión abdominal, signos de deshidratación.

- **Auscultación:** disminución o abolición del peristaltismo en la peritonitis; ruidos intestinales aumentados o con sonido metálico sugieren obstrucción.
- **Percusión:** matidez o timpanismo. Ayuda en la valoración de irritación peritoneal, ascitis, visceromegalias, etc.
- **Palpación** (superficial y profunda): masas, megalias, hernias, defensa abdominal, dolor a la palpación, asimetría de pulsos femorales, signos de irritación peritoneal. No olvidar la exploración de orificios herniarios.
- **Tacto rectal:** tono esfínter anal, presencia de heces en ampolla y sus características, existencia de masas o nódulos, valoración prostática (en hombres).

Pruebas complementarias

- Hemograma con fórmula y recuento leucocitario.
- Bioquímica: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, bilirrubina, amilasa, GOT, GPT, LDH, procalcitonina, proteína C reactiva (PCR).
- Coagulación básica.
- Sistemático y sedimento de orina.
- Test de embarazo en pacientes en edad fértil.
- ECG: descarta cardiopatía isquémica.
- Radiología: esencial para la valoración de todo dolor abdominal.
 - Rx tórax posteroanterior y lateral.
 - Rx abdomen en decúbito supino.
 - Rx abdomen en bipedestación o decúbito lateral: en caso de duda diagnóstica.

NEUMOPERITONEO	SUGIERE PERFORACIÓN DE VÍSCERA HUECA
• Niveles centroabdominales	• Sugiere obstrucción de intestino delgado
• Niveles en marco cólico	• Sugiere obstrucción de intestino grueso

- Ecografía abdominal: valoración de cuadros de dolor abdominal de etiología incierta para apoyar sospecha diagnóstica. Es la prueba gold standard en los casos de patología biliar.
- TAC abdominal: En situaciones de duda diagnóstica una vez realizadas previamente las pruebas necesarias antes descritas. (peritonitis global, oclusión mecánica intestinal, sospecha de disección aórtica e isquemia mesentérica aguda).

Diagnóstico diferencial de los cuadros clínicos más frecuentes

	Apendicitis	Colangitis y colecistitis litiasicas	Úlcus péptico perforado	Intestinal oclusivo	Intestinal isquémico
Localización	F.I.D.	H.D.	Epigastrio	Centro-abdominal	Periumbilical
Irradiación	F.I. D. e hipogastrio	Escápula y hombro derecho	Fijo	Difusa	Difusa
Carácter	Continuo	Intenso y continuo	Sordo y urente	Cólico	Súbito y constrictivo
Ritmo	Inicio progresivo	Inicio brusco	Brusco, postprandial	Crisis a intervalos	Postprandial
Signos y síntomas asociados	Fiebre, náuseas y vómitos.	Fiebre, vómitos +/- ictericia	Náuseas, distensión abdominal	Peristaltismo de lucha	Sudoración. Diarrea sanguinolenta
Analítica	Leucocitosis	Leucocitosis, +/- aumento de GGT y ALP.	Normal /leucocitosis	Normal	Leucocitosis intensa

	Apendicitis	Colangitis y colecistitis litiasicas	Úlcus péptico perforado	Intestinal oclusivo	Intestinal isquémico
Diagnóstico	Clínico y analítico	Clínico y ecográfico.	Clínico. Rx y/o T.C.	Rx y/o T.C.	Angio-T.C.
Tratamiento	Quirúrgico	Médico / quirúrgico	Quirúrgico	Médico / quirúrgico	Quirúrgico

Lectura: F.I.D: Fosa Ilíaca derecha. F.D.: Flanco derecho. H.D.:Hipocondrio derecho T.C.: Tomografía computada.

TRATAMIENTO

La actitud terapéutica en urgencias se encaminará al tratamiento etiológico del dolor abdominal. Valorar la estabilidad hemodinámica del paciente.

- Aspecto general del paciente.
- Toma de constantes: TA, FC, FR y T^a.
- Determinar nivel de conciencia.
- Medidas generales
 - Dieta absoluta.
 - Sueroterapia según situación clínica y patología de base: suero fisiológico 0,9% 500ml IV o suero glucosalino 500ml IV o suero glucosado 5% 500ml, según necesidad del paciente.
 - Sondaje nasogástrico en cuadros de oclusión intestinal.
 - Analgesia. Paracetamol 1 gr IV. Su utilización debe ser individualizada. Un dolor intenso tras ser analgesiado un paciente sugiere patología abdominal quirúrgica grave.
 - Protección gástrica: pantoprazol 1 amp IV.
 - Antibioterapia: en los casos de abdomen agudo inflamatorio-infeccioso que cubra bacterias gramnegativas y anaerobias, antes de iniciar iniciarlo hemocultivos x2.
- Tratamiento específico del cuadro clínico.
- De causas quirúrgicas o médicas: interconsultar con cirugía general o especialidad correspondiente.

BIBLIOGRAFÍA

- Jiménez A. Manual de exploración. Propedéutica clínica. 3^a ed. Universidad de Salamanca; 2000.
- Silen W. Cope's early diagnosis of the acute abdomen. 21^o ed. New York: Oxford University Press; 2005.
- Flasar MH, Goldberg E. Acute abdominal pain. Med Clin North AM. 2006;90(3):481-503.
- Cartwright SL, Knudson MP. Evaluation of acute abdominal pain in adults. Am Fam Physician, 2008;77(7):971-8.
- Jiménez Murillo L, Montero Perez FJ, Medicina de Urgencias y Emergencias: Guía diagnóstica y protocolos de actuación. 6^aed Madrid: Elsevier, 2018, 754-761.